

1

CLASSIFICAR

antes de medicar

2

TRATAR AGORA

comece já

| Gravidade                               | Como reconhecer — olhe FALA, POSTURA, RESPIRAÇÃO, OXÍMETRO                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>LEVE</div> <div>todos</div>        | Fala <b>frases inteiras</b> · <b>consegue deitar</b> · não agitado<br>FR normal ou pouco aumentada · pouca ou nenhuma musculatura acessória<br>SpO <sub>2</sub> ≥ 94% · PFE > 70% do previsto               |
| <div>MODERADA</div>                     | Fala por <b>frases curtas</b> · <b>prefere sentar</b> a deitar · não agitado<br>FR aumentada, mas ≤ 30/min · <b>usa musculatura acessória</b> · murmúrio diminuído<br>SpO <sub>2</sub> ≥ 92% · PFE 50 – 70% |
| <div>GRAVE</div> <div>qualquer um</div> | Não consegue falar, beber nem deitar<br>FR > 30/min · <b>TÓRAX SILENCIOSO</b> ou muito diminuído<br>SpO <sub>2</sub> < 92% · PFE < 50%                                                                      |
| <div>AMEAÇA À VIDA</div>                | <b>SONOLENTO · CONFUSO · CIANÓTICO</b> — e SpO <sub>2</sub> < 90% = <b>tratamento intensivo</b> (PCDT p.27)                                                                                                 |

1. SALBUTAMOL

INALATÓRIO

não consta na farmácia

**4 a 10 jatos · a cada 20 min · por 1 hora**  

pMDI + **espaçador** (preferencial). Até **3 séries** na 1ª hora.  
 Depois — melhorou: 4-10 jatos a cada 3-4 h · ainda ruim: 6-10 jatos a cada 1-2 h.

↳ 20 min porque o pico é 30-60 min — *empilha dose antes do pico sem somar tremor.*

2. PREDNISONA

VIA ORAL

✓ na farmácia

**40 a 50 mg/dia · 5 a 7 dias**  

**2 comprimidos de 20 mg**, dose única **pela manhã**. **Sem desmame** se usar < 2 semanas.

**Criança:** prednisolona 3 mg/mL ✓ — **1 a 2 mg/kg/dia (máx 40 mg) · 3 a 5 dias.**

↳ *Só age em 4-6 h — comece cedo, junto do broncodilatador, nunca no lugar dele.*

3. NÃO CONSEGUE ENGOLIR?

INTRAVENOSO

✓ na farmácia

**Hidrocortisona 200 mg · IV · 6/6 h**  

Só se vomita, está rebaixado, não deglute ou em choque — **até conseguir a via oral.**

O PCDT da Asma prevê o corticoide sistêmico “por via oral **ou injetável**” (Quadro 6, p.24), mas **não crava dose parenteral**; a dose acima é a do **PCDT da DPOC, p.22.**

↳ *Cada um desses motivos já é, sozinho, critério para acionar a regulação.*

3

OXIGÊNIO

4

REAVALIAR

os dois relógios

**Alvo de saturação: 92 a 95%** (criança 94-98%).  
 Cateter nasal ou máscara simples. **O protocolo pede “oxigênio controlado”** — titule pelo oxímetro, não deixe no máximo.  
 Na asma não há retenção de CO<sub>2</sub> como na DPOC — mas use o necessário.

20 – 60 min

se usou **só broncodilatador** — mede o músculo relaxando

3 – 4 horas

se usou **corticoide** — mede a inflamação cedendo

↳ *Passou o prazo sem melhorar = **falha terapêutica**. O problema já não é só broncoespasmo → acione a regulação.*

🔥

**ACIONE A REGULAÇÃO — o paciente não pode mais ficar aqui**

- SpO<sub>2</sub> < 90%
- Não fala frases**, não deita, não bebe
- Tórax silencioso** · sonolência · confusão · cianose
- Sem resposta** em 1 h de broncodilatador ou 3-4 h com corticoide
- Precisou de **corticoide na veia**

- Suspeita de **pneumonia, pneumotórax** ou outra causa (IC, obstrução de laringe)
- CRIANÇA:** prostrada · não responde ao jato · piorando · **menor de 1 ano**
- CRIANÇA:** precisou de ≥ 4 jatos em 4 h ou **SABA > 3x em 12 h**

📞 **O QUE FALAR:** não diga “asmática que não melhorou”. Diga **o número e o achado** — “*crise asmática sem resposta a 3 séries de salbutamol em 1 hora, SpO<sub>2</sub> 88%, falando por palavras.*” Quem recebe decide o destino; você entrega o quadro objetivo.

✓

**ESTABILIZOU — o que fazer ANTES de sair · RETORNO EM 2 A 7 DIAS** (criança 1 a 2 dias)

**A crise não termina quando o chiado passa — termina quando estes 7 itens estão feitos.**

- 1. Sai com o tratamento OTIMIZADO:** manutenção com **corticoide inalatório** (beclometasona ✓) na **etapa 3 ou 4**. **Nunca alta só com bombinha de alívio.**
- 2. A crise mudou o grau?** Veio depois de meses mal controlado → **intensifique**. Voltar ao mesmo esquema é reprogramar a próxima crise.
- 3. Plano de ação POR ESCRITO na mão:** o que fazer ao piorar e quando procurar ajuda. Revise a cada consulta.
- 4. Técnica: peça para DEMONSTRAR** — não pergunte “sabe usar?”. **Com espaçador.**
- 5. Adesão sem julgamento:** “muita gente esquece — **quantos dias você usou na semana passada?**”
- 6. Vacinas: influenza e covid-19.** A maioria das crises começa com vírus — vacinar é tratar a doença.
- 7. Ache o GATILHO:** vírus · parou a medicação · alérgeno · fumaça · clima · exercício · anti-inflamatório.

**Fontes** — PCDT Asma (Portaria Conjunta nº 43, 24/03/2026): gravidade e conduta na APS p.27 · tórax silencioso p.9 · relógios p.13 · salbutamol §7.4.1 p.39 · corticoide oral p.38 · alta §7.2 p.28 · monitoramento §8 p.41 · vacinas p.23 · encaminhamento criança p.36. Faixa-alvo de SpO<sub>2</sub> e classificação leve/moderada/grave: GINA 2026 (referência adotada pelo próprio PCDT).

**⚠ Disponibilidade** — as marcações referem-se à **lista de dispensação da farmácia (03/08/2026)**. Pode haver estoque na sala de medicação ou de uso exclusivo da enfermagem — confirmar antes de assumir indisponibilidade. **Doses aqui são as do PCDT, independentemente do estoque local.**

1 CLASSIFICAR
 antes de medicar
 2 TRATAR AGORA
 comece já

Na entrada, três coisas: ① achar a causa (vírus é a mais comum · poluição · frio · parou a medicação) · ② ver sinais de gravidade (FR, FC, musculatura acessória, **nível de consciência**) · ③ ajustar o broncodilatador de curta ação, iniciando corticoide ou antibiótico se indicado.

| Gravidade | Como reconhecer (beira do leito)                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEVE      | Dispneia leve · FR < 24 · FC < 95 · SaO <sub>2</sub> ≥ 92% em ar ambiente                                             |
| MODERADA  | 3 ou mais de 5: dispneia importante · FR ≥ 24 · FC ≥ 95 · SaO <sub>2</sub> < 92% · PCR ≥ 10                           |
| GRAVE     | Mesmos sinais da moderada + <b>gasometria alterada</b> : PaO <sub>2</sub> ≤ 60 · PaCO <sub>2</sub> > 45 com pH < 7,35 |

⚠ SpO<sub>2</sub> < 92% → indicar **GASOMETRIA** (PCDT p.6)  
 ↳ Se a unidade não realiza gasometria, este é o seu gatilho de encaminhar — o critério que define “grave” só se mede no serviço.

1. SALBUTAMOL INALATÓRIO não consta na farmácia  
 2 a 4 jatos (200-400 mcg)  
 Na exacerbação, **pode repetir a cada 20 min nas primeiras horas, sob monitoramento**. Depois, a cada 4-6 h.  
 Nebulização (só para quem não consegue usar o dispositivo): 2,5 mg em 2-4 mL de SF 0,9%.  
 ↳ O idoso cardiopata tolera menos β<sub>2</sub> — por isso “sob monitoramento”: olho na frequência cardíaca e no tremor.

2. IPRATRÓPIO INALATÓRIO não consta na farmácia  
 40 mcg (2 jatos) · junto com o salbutamol  
 Máx 240 mcg/dia · nebulização 0,25-0,5 mg (20-40 gotas) a cada 4-6 h, diluído até 3-4 mL. ⚠ **Vede a máscara** — jato no olho pode desencadear **glaucoma agudo**.  
 ↳ Na DPOC ele **não é opcional**: bloqueia o tônus vagal, que é a via que o salbutamol não alcança.

3. PREDNISONA VIA ORAL ✓ na farmácia  
 40 mg/dia · 5 dias  
 2 comprimidos de 20 mg pela manhã. Nas exacerbações moderadas e graves.  
 Sem melhora no 5º dia → pode estender para **10 a 14 dias**. Desmame só se usar > 3 semanas.  
 NÃO ENGOLE? IV Hidrocortisona 200 mg IV 6/6 h ✓ — até conseguir a via oral.  
 ↳ Se ele engole, é via oral — a veia adianta 30 min numa corrida de 6 h e só acrescenta toxicidade.

3 OXIGÊNIO
 o ponto mais perigoso
 4 ANTIBIÓTICO
 só se indicado

ALVO 88 – 92%. **NÃO MAIS QUE ISSO**.  
 Máscara de Venturi 24-35% ou cateter em baixo fluxo. **NUNCA** máscara com reservatório.  
 ↳ O<sub>2</sub> demais faz a perfusão voltar para alvéolos que não ventitam → espaço morto → **CO<sub>2</sub> sobe**. Dá para estar com SpO<sub>2</sub> 98% e pH 7,20. Subiu o O<sub>2</sub>? Peça gasometria.

Indicado quando há **escarro purulento** associado a aumento da dispneia ou do volume de secreção. **5 a 7 dias**.  
 Na farmácia: ✓ amoxicilina+clavulanato ✓ azitromicina  
✓ claritromicina ✓ SMX-TMP  
 ↳ O PCDT pede prescrição  **criteriosa** (risco de resistência) — não é para toda exacerbação. **Na asma, NUNCA** por exacerbação.

ACIONE A REGULAÇÃO — os 9 critérios do protocolo

FALHA DO TRATAMENTO · resposta insatisfatória ao tratamento aqui · **piora importante da dispneia**  
 FALÊNCIA DO CORPO · PaO<sub>2</sub> < 50 mmHg · pH < 7,3 · **alteração do estado mental** · não consegue dormir nem se alimentar pelos sintomas  
 FALHA DE CONTEXTO · **não consegue se cuidar ou não tem quem cuide em casa** · dúvida no diagnóstico · comorbidade importante (pneumonia, cardiopatia, diabetes, insuficiência renal)  
 ⚠ Dois avisos: “alteração do estado mental” aqui é **CO<sub>2</sub> alto**, não cansaço — pede gasometria e VNI. E **3 dos 9 critérios são sociais**: prescrição que não pode ser cumprida em casa é prescrição que falhou.  
 📞 O QUE FALAR: “exacerbação de DPOC, **rebaixando o nível de consciência, provável hipercapnia, candidato a ventilação não invasiva** — não tenho gasometria aqui.” pH < 7,3 e alteração do estado mental são os dois achados que mais aceleram a vaga.

ESTABILIZOU — o que fazer ANTES de sair · RETORNO EM 1 A 4 SEMANAS (funcional em 12-16 sem)

Metade volta em 30 dias após uma exacerbação. Não é falha do paciente — é falha da alta.

- 1. Manutenção REVISTA conforme o grupo. Corticoide inalatório sozinho não se usa na DPOC — só em tripla.
- 2. Reclassifique A · B · E. Esta crise já mudou a conta: 2ª moderada no ano ou 1 internação → grupo E.
- 3. CESSAÇÃO DO TABAGISMO — “a intervenção mais eficaz”, a única que muda a progressão. Ofereça sempre.
- 4. Técnica: peça para DEMONSTRAR — “monitorada em todas as consultas”. Com espaçador (reduz candidíase e rouquidão).
- 5. Adesão, sem julgamento — técnica errada é a causa mais comum de falha
- 6. Vacinas: influenza anual (todos) · pneumocócica 13 + 23 (sintomáticos e exacerbadores) — 6 meses de intervalo, começando pela 13.
- 7. Plano escrito + reabilitação pulmonar, atividade física, nutrição.

Fontes — PCDT DPOC (Portaria Conjunta nº 29, 27/11/2025): avaliação inicial e critérios de hospitalização p.11 · gasometria por SpO<sub>2</sub> < 92% p.6 · classificação ABE Quadro 3 p.6 · SABA e ipratrópio Quadro 6 p.19-20 · ipratrópio p.15 · corticoide sistêmico p.22 · via oral preferencial p.18 · ventilação não invasiva §7.1.5 p.13 · vacinas §7.4 p.23 · monitoramento §8 p.26-27. Gravidade de beira de leito (proposta de Roma) e alvo de SpO<sub>2</sub>: GOLD 2026 (referência adotada pelo próprio PCDT).  
 ⚠ Disponibilidade — as marcações referem-se à lista de dispensação da farmácia (03/08/2026). Pode haver estoque na sala de medicação ou de uso exclusivo da enfermagem — confirmar antes de assumir indisponibilidade. Doses aqui são as do PCDT, independentemente do estoque local.